

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA				
	FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM						
	Código: IVC-VIG-FM026		Versión: 01		Fecha de Emisión: 05/04/2016		Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE							
Fecha de notificación	Origen del reporte		Nombre de la Institución donde ocurrió el evento			Código PNF	
	Departamento – Municipio						
2023-04-17	BOGOTA D.C - BOGOTA		DOMICILIO				
Nombre del Reportante primario	Nombre del Paciente o Acudiente		Consecutivo		Profesión del reportante primario		
Ana Yeimi Sanchez Lozano	PACIENTE		BTLKydOd		ENFERMERA		
Correo electrónico institucional del reportante primario							
asanchez@encontactopeoplemarketing.com							

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE						
Fecha de nacimiento del paciente	Edad del paciente en el momento del EA	Documento de identificación del paciente	Iniciales del paciente	Sexo	Peso	Talla
	Edad – Años/Meses/ días	CC TI RC NUIP Cód. Lab Otro S/I		M F S/I	(Kg)	(cm)
1960-12-05	62	C.C - 79119642	FHGG	M	66	160
Diagnóstico principal y otros diagnósticos:						
CARCINOMA DE CELULAS RENALES						



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS								
Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S” el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.								
S/C/I	Medicamento (Denominación Común Internacional o Nombre genérico)	Indicación	Dosis	Unidad de medida	Vía de administración	Frecuencia de administración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
S	CABOZANTINIB	TUMOR MALIGNO DE RIÑON	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	25/03/2023	31/03/2023
S	CABOZANTINIB	TUMOR MALIGNO DE RIÑON	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	11/03/2023	ACTUALMENTE
C	LEVOTIROXINA	CONTROL DE LA HORMONA TIROIDEA	100	MCG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	PREDNISOLONA	CORTICOIDE	5	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	IVERSARTRAN	HIPERTENSION	150	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	ATORVASTATINA	DISLIPIDEMIA	40	MG	ORAL	CADA 48 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	ACIDO ASCORBICO	DEFICIT VITAMINA C	500	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	VITAMIMIDA D	DEFICIT VITAMINA D	2000	UI	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	SULFATO FERROSO	DEFICIT DE VITAMINA	300	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	ACIDO FOLICO	DEFICIT DE VITAMINA	1	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	BROMURO IPATROPIO	BRONCODILATADOR	2	PUFF	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
Información comercial del medicamento sospechoso								
Titular del Registro sanitario			Nombre Comercial		Registro sanitario		Lote	
			CABOMETIX		SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN	

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO			
Fecha de Inicio del Evento Adverso: 2023-03-31		Evento adverso: HOSPITALIZACION POR DOLOR EN EL PECHO - SUSPENCIÓN TEMPORAL DE CABOZANTINIB	
Descripción y análisis del Evento Adverso: SE REALIZA COMUNICACIÓN CON PACIENTE YA QUE EN ANTERIORES SEGUIMIENTO NO SE HABÍA LOGRADO CONTACTO, DONDE INFORMA QUE EL 31 DE MARZO DEL 2023 TUVO QUE ACUDIR A URGENCIAS POR DOLOR EN EL PECHO. ESTANDO HOSPITALIZADO LE REALIZARON ESTUDIOS PARA DESCARTAR INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO Y DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN , LE INDICARON SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL MEDICAMENTO CABOZANTINIB, EL CUAL REINICIO NUEVAMENTE EL 11 DE ABRIL. PACIENTE NO BRINDA MAS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE DONDE FUE LA HOSPITALIZACION		Desenlace del evento (Marcar con una X) Recuperado / Resuelto sin secuelas Recuperado / Resuelto con secuelas ☒ Recuperando / Resolviendo No recuperado / No resuelto Fatal Desconocido	
		Seriedad (Marcar con X) ☒ Produjo o prolongó hospitalización Anomalía congénita Amenaza de vida Muerte (Fecha: _____) Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición médica importante Ninguno	

	Si	No	No sabe
¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?	X		
¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?	X		
¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?			X
¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?			X
¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?	X		